2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

INDICADOR DE BOAS PRÁTICAS NO CUIDADO A PESSOAS COM DIABETES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gledsângela Ribeiro Carneiro[1]
Valerio Severino da Silva[1]
Milena Rafaela Mendes de Albuquerque [1]

[1] Secretaria de Saúde do Recife – SESAU

Inicialmente, a equipe atuava de forma descentralizada e poucos usuários realizavam consulta de enfermagem. Após reorganização do processo de trabalho entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, foram ampliadas as consultas e avaliações clínicas. Entre 233 usuários com diagnóstico de diabetes acompanhados pela equipe, passou-se de nenhum registro de avaliação dos pés para 100 avaliações realizadas no período pela equipe. A expectativa é avaliar todos os pacientes em até seis meses. Aprendizado: A reorganização do trabalho em equipe e a ampliação das consultas de enfermagem fortaleceram o acompanhamento dos usuários, qualificando o cuidado e contribuindo para a prevenção de complicações na atenção primária.

INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus constitui um dos principais problemas de saúde pública entre as doenças crônicas não transmissíveis, apresentando elevada prevalência e impacto significativo na morbimortalidade da população. Seu controle adequado depende do diagnóstico precoce, do acompanhamento longitudinal e da organização dos serviços de saúde, especialmente nas áreas adstritas das Unidades de Saúde da Família (USF) (Silva *et al.,* 2023).
O manejo inadequado do diabetes pode resultar em complicações graves e potencialmente evitáveis, como retinopatia diabética (com risco de cegueira), nefropatia diabética (evoluindo para doença renal crônica) e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Essas complicações geram impacto negativo na qualidade de vida dos usuários, além de elevar significativamente os custos para o sistema de saúde (Silva *et al.,* 2023).
A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha papel central no cuidado às pessoas com diabetes, por meio de estratégias de detecção precoce, acompanhamento contínuo, educação em saúde e monitoramento clínico. Entre essas ações, destaca-se a avaliação periódica dos pés, fundamental para prevenção de úlceras e amputações.
Nesse contexto, a organização do processo de trabalho das equipes de saúde é essencial para garantir a integralidade do cuidado e ampliar o acesso dos usuários às ações recomendadas.

OBJETIVO

Apresentar a experiência de reorganização do processo de trabalho e do acompanhamento de pessoas com Diabetes Mellitus por uma equipe de Saúde da Família de um município do estado de Pernambuco.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em uma Unidade de Saúde da Família (USF) de um município do estado de Pernambuco.
A intervenção ocorreu no período de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026 e consistiu na reorganização do processo de trabalho da equipe, com ênfase na ampliação das consultas de enfermagem e na qualificação do acompanhamento clínico dos usuários com diagnóstico de diabetes mellitus.
Foram adotadas estratégias como: reorganização da agenda, definição de fluxos assistenciais, intensificação da busca ativa de usuários e fortalecimento das ações programáticas voltadas para o cuidado das condições crônicas. A avaliação clínica passou a incluir, de forma sistemática, o exame dos pés.
Os dados foram obtidos a partir dos registros da equipe, considerando o número total de usuários com diabetes acompanhados e a realização de avaliações específicas, como o exame dos pés. A análise foi conduzida de forma descritiva, com base em frequências absolutas.
Por se tratar de relato de experiência com dados secundários e sem identificação dos participantes, foram respeitados os princípios éticos vigentes, não sendo necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Inicialmente, a equipe atuava de forma descentralizada, com baixa adesão dos usuários às consultas de enfermagem e ausência de registro sistemático de avaliações clínicas específicas, como o exame dos pés.
Após a reorganização do processo de trabalho, observou-se ampliação significativa das consultas de enfermagem e das avaliações clínicas realizadas. Entre os 233 usuários com diagnóstico de diabetes acompanhados pela equipe, passou-se de nenhum registro de avaliação dos pés para a realização de 100 avaliações no período analisado.
A implementação dessas ações possibilitou maior aproximação da equipe com os usuários, além de qualificar o acompanhamento longitudinal. A expectativa é atingir a avaliação de todos os pacientes cadastrados em um período de até seis meses.

APRENDIZADO

A experiência demonstra que a reorganização do processo de trabalho na Atenção Primária à Saúde pode impactar positivamente a qualidade do cuidado ofertado às pessoas com doenças crônicas. A ampliação das consultas de enfermagem mostrou-se uma estratégia eficaz para fortalecer o acompanhamento clínico e ampliar o acesso dos usuários.
A incorporação da avaliação sistemática dos pés representa um avanço importante na prevenção de complicações, contribuindo para redução de agravos evitáveis, como úlceras e amputações. Além disso, a atuação integrada da equipe e a definição de fluxos assistenciais mais eficientes favoreceram a continuidade do cuidado.

CONCLUSÃO

A reorganização do processo de trabalho e a ampliação das consultas de enfermagem fortaleceram o acompanhamento de pessoas com Diabetes Mellitus na Atenção Primária à Saúde, qualificando o cuidado e contribuindo para a prevenção de complicações. Estratégias semelhantes podem ser replicadas em outros contextos, com potencial para melhorar os indicadores de saúde relacionados às condições crônicas.

REFERÊNCIA

Silva, Andreia Matos, Carmo, Ariane Silva, Alves, Vicente Paulo; Carvalho, Luiz Sergio F. Prevalência das doenças crônicas não transmissíveis: hipertensão arterial, diabetes mellitus e fatores de risco associados em pessoas idosas longevas. 2023. Revista Brasileira de Enfermagem. 76. DOI:10.1590/0034-7167-2022-0592pt.

Gledsângela Ribeiro Carneiro
Secretaria de Saúde do Recife

E-mail: gleds_r1@hotmail.com
Contato: 81 98532-8811

RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE
POR VOCÊ, TRABALHANDO SEM PARAR.